

仿單、標籤貼表

衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	產品名稱 / Cefin for IV injection “Panbiotic” (Ceftriaxone)	“汎生”舒復靜脈注射劑 (西華崙隆)
	申請廠商	臺灣汎生製藥廠股份有限公司

嬰兒和小兒的細菌性眼膜炎，剛開始治療時，日劑量為100 毫克/公斤（最大可至4 克），直到致病菌被鑑定出來，且感受性也被確認後，劑量可依據調低。

在下列的治療期間可獲得很好的治療結果：

腦膜炎雙球菌(Neisseria meningitidis) 4天
感冒嗜血桿菌(Haemophilus influenzae) 6天
肺炎雙球菌(Streptococcus pneumoniae) 7天

萊姆病(Lyme borreliosis)

小孩和成人的劑量為50 毫克/公斤，最多可至2克，每日一次，共14天。

手術周期的預防感染

依據感染的危險性，在開刀前 30-90 分鐘投予單一劑量 Ceftriaxone 1-2 克。在直腸外科手術，投予Ceftriaxone，併用或不併用 5-nitro-imidazole 如 ornidazole (分開投予，見 2.2 用法用量)，證實可有效的預防感染。

2.3 禁忌(依文獻記載)

已知對cephalosporins 抗生素過敏的病人不能使用 Ceftriaxone，對penicillin 過敏的病人也可能會對Ceftriaxone 產生過敏反應。

高膽紅素血症的新生兒和早產而不得使用 Ceftriaxone 治療。在體外試驗顯示，ceftriaxone 可從血清 albumin 中將 bilirubin 取代出來，導致這些病人可能有發展成膽紅素腦病的風險。

Ceftriaxone 僅用於需要(或預期需要)接受含鈣溶液治療新生兒(≤28 天)，包括含鈣溶液持續靜脈輸注如靜脈營養，因為會有產生 ceftriaxone-calcium 沉澱的風險(見 2.2 用法用量和 2.4.4 與其他藥品間的交互作用以及其它形式的交互作用)。在少數病例用Ceftriaxone與含鈣溶液的注射劑發生少數致死性的案例中，在解剖報告中，曾在肺及腎臟察到結晶的物體。在某些案例中，Ceftriaxone 與含鈣溶液使用相同的輸注管時，在輸注管壁中會觀察到一些沉澱。至少有一新生兒死亡報告，是在不同的時間經由不同的輸注管接收與 Ceftriaxone 及含鈣溶液；在該新生兒案例的解剖報告中並無觀察到結晶的物體。除了新生兒以外，其他病人並無類似的報告(見 2.6.1 上市後經驗)。

2.4 警告及注意事項(依文獻記載)

2.4.1 一般

和其他cephalosporins 一樣，在沒有過敏或先前未使用過此類藥物的病人，曾有致命的過敏反應被報導過。

使用 cephalosporin 類的抗菌劑，包括Ceftriaxone 的病人，有報導過免疫球蛋白血症。在成人與兒童皆曾被報導在服藥期間發生嚴重溶血性貧血的案例，包含死亡。如果病人在使用 ceftriaxone 期間產生貧血，必須考慮是否為cephalosporin 引發的貧血，且在確認出貧血的原因之前，必須中止 ceftriaxone 的治療。幾乎所有抗菌劑，包括Ceftriaxone 皆有發生與 Clostridium difficile 有關的腹瀉(CDAD)的報告，且其嚴重程度可能從輕度腹瀉到致死性結腸炎。抗菌劑的治療會改變正常的腸道菌叢，而導致 C. difficile 的過度生長。

C. difficile 會製造促成 CDAD 產生的毒素 A 和B，會過度產生毒素的C. difficile 菌叢會增加發病率和致死率，因為這些感染可能難以抗菌劑治療且可能需要結腸切除治療。針對所有使用抗生素後發生腹瀉的病應考量是否為 CDAD，因為CDAD曾被報導在停用抗菌劑超過2 個月後發生，因此必須詳細評估其病史。

如果懷疑或確認為 CDAD，目前使用的非針對 C. difficile 的抗生素可能也必須停止，必須依照臨床狀況，給予適時的流體或電解質管理、補充蛋白質，給予治療C. difficile 的抗生素和建立外科手術的評估。和其他的抗菌劑一樣，也可能受感受性差的微生物(non-susceptible microorganisms)重複感染(superinfection)。

通常給予超過標準建議劑量的劑量後，在作膽道超音波時會看到陰影，而這些陰影曾被誤以為是膽結石。然而事實上，這些陰影是ceftriaxone 的鈣鹽沉澱物，通常在完成或停止Ceftriaxone 的治療後，即可消失。這些現象幾乎沒有伴隨臨床症狀。

對有發生臨床症狀的案例而言，建議採取保守的非外科手術處理。

同時若須藉由停止Ceftriaxone 的療程而來改善臨床症狀的案例，則須經由醫師作慎重的判斷。

根據已知的學術資料，給予ceftriaxone 及含鈣溶液或其他含鈣的產品，除了新生兒以外，並無血管內沉澱的報告。然而，即使是經由不同輸注管時，ceftriaxone 仍不得與含鈣溶液混合或同時注射。(見2.3 禁忌中有關新生兒資訊一段、2.4.4 與其他藥品間的交互作用以及其它形式的交互作用和 2.6.1 上市後經驗)。

有極少數使用Ceftriaxone 治療的病人有發生心臟病的案例，其病因學可能是因為體道阻塞而引起的。臨床大部分病人都有造成體道鬱滯和體道淤泥的危險因子，例如進行大規模的治療、嚴重疾病和進行全身靜脈營養輸注。Ceftriaxone 相關的體道沉澱物的起因和輔助因子的角色不能被排除在外。Ceftriaxone 在新生兒、嬰兒和小孩的安全性和有效性已建立完成，在用法用量的章節有詳細介紹。研究顯示ceftriaxone 和其他一些 cephalosporins 相同，可從血清albumin 中將 bilirubin 取代出來，Ceftriaxone 不可用於有發展膽紅素腦病風險的新生兒(尤其是早產兒)(見 2.3 禁忌)。長期治療時，須定期檢查全血球計數。

2.4.2 藥物濫用及依賴性

不適用

2.4.3 駕駛及機器操作能力

沒有數據指出對服用者的駕駛和使用機器的能力有任何影響。

2.4.4 與其他藥品間的交互作用以及其它形式的交互作用

何用大劑量的Ceftriaxone 和強效利尿劑(如：furosemide)，至目前為止的觀察，並沒有傷害腎臟的功能，也沒有證據顯示Ceftriaxone 會增加 aminoglycosides 的腎毒性。使用Ceftriaxone 後，喝酒也不會產生像使用disulfiram後所引起的副作用。Ceftriaxone 不含其他某些 cephalosporins 中可能會引起的ethanol 無法耐受性和出血現象的N-methylthiotetrazole基。Ceftriaxone 的排除作用不會被probenecid 改變。體外的實驗顯示，併用chloramphenicol 和ceftriaxone 會有拮抗作用。

不可使用含鈣溶液(例如 Ringer’s 溶液或 Hartmann’s 溶液)配製Ceftriaxone 小瓶或進一步稀釋已配製後之小瓶，因為會產生沉澱。當 Ceftriaxone 與含鈣溶液在同一個靜脈注射管混合時，也會發生 ceftriaxone-calcium 沉澱。Ceftriaxone 不應與含鈣靜脈注射液同時投與，包括含鈣溶液持續靜脈輸注，如經由 Y 型管投與之非腸道營養。然而，在新生兒以外的病人，如果可以在兩次輸注之間徹底以可相容的溶液沖洗輸注管，則可以相繼使用 Ceftriaxone 與含鈣溶液。根據成人和由臍帶血取得的新生兒血漿的體外研究結果，證實新生兒發生 ceftriaxone-calcium 沉澱的風險較低(見 2.2 用法用量見 2.3 禁忌)。

依據文獻報告，ceftriaxone 和amsacrine、vancomycin、fluconazole 及aminoglycosides 均不相容。

2.5 特殊族群的使用(依文獻記載)

2.5.1 懷孕

Ceftriaxone 會穿過胎盤障壁。對於人類懷孕之安全性尚未建立。以動物實驗來研究生殖能力，沒有證據顯示有胚胎毒性、胎兒毒性、致畸胎性或對男性或女性生育力、生產或週產期(perinatal)和產後的(postnatal)的發育有不良作用。

在靈長類動物並未觀察到胚胎毒性或致畸胎性。

2.5.2 授乳母親

低濃度ceftriaxone 會分泌於人類乳汁，授乳婦女務請小心使用Ceftriaxone。

2.5.3 兒童使用

見特殊劑量指示。

2.5.4 老年人使用

見特殊劑量指示。

2.5.5 腎功能受損

見特殊劑量指示。

“汎生”
頭孢子菌素類抗生素
舒復靜脈注射劑 (西華崙隆)
Cefin for IV injection “Panbiotic” (Ceftriaxone)

衛署藥製字第038615號 G-2639

(1)未滿28 (≤28) 天的新生兒正以靜脈注射方式接受含鈣藥品及營養品，則這些新生兒不應再投予Ceftriaxone 成分之注射劑。(2)於28 (>28) 天以上的病人，可以相繼使用含Ceftriaxone 與含鈣藥品，但是輸注管必須完全以可相容的溶液沖洗。(3)Ceftriaxone 與含鈣藥品不應以Y 型管同時投予病人。(4)因為Ceftriaxone-calcium 沈澱發生於大於28 (>28) 天以上的病人之風險很小，因此這些病人可以同時使用Ceftriaxone 與含鈣產品，但必須遵循前述指示使用。另外不可以將Ceftriaxone 與含鈣產品，包括Ringer’s 或Hartmann’s 溶液或非口服方式之含鈣營養品等混合使用。根據額外研究結果發現，如果遵循前述注意事項使用Ceftriaxone 與含鈣溶液或其產品，發生Ceftriaxone-calcium 沈澱的風險很低。(5)目前並沒有資料顯示靜脈輸注Ceftriaxone 與口服含鈣產品或肌肉注射Ceftriaxone 與靜脈注射或口服含鈣產品之間不會發生沈澱。

廣效的cephalosporin 抗生素製劑

1. 說明

1.1 治療/藥理分類

本品是一作用時間長，且廣效的注射用cephalosporin 抗生素製劑

1.2 成份含量

主成份：ceftriaxone 雙鈉鹽。

每小瓶含：

Ceftriaxone (as Disodium 3.5 H2O) 0.25克；0.5克；1克；2克 (Potency)

2. 臨床特性

2.1 適應症

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、膜膿球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

說明：適應症屬所述之感染症，例如：敗血症、腦膜炎、擴散性萊姆病(包括早期及晚期)；腹部感染症(包括腹膜炎、膽道及胃腸道感染)；骨、關節、軟組織、皮膚及傷口之感染；免疫機能受損之感染病患；腎臟及泌尿道之感染；呼吸道感染(特別是肺炎、耳鼻喉之感染)；生殖道感染(包括淋病)。

2.2 用法和用量

標準劑量

成人和12歲以上的孩童。

一般劑量為Ceftriaxone 1-2克，每天一次（每24小時）。在最嚴重的感染或致病菌對Ceftriaxone 的感受性僅是中等時，其劑量可能增加至4 克，一天給藥一次。

治療期間

療程會因疾病的進程而改變，以抗生素療法的一般原則而言，在病人退熱或經證實已根絕細菌後，Ceftriaxone 仍舊繼續投藥至少48-72小時。

合併療法

由實驗得知Ceftriaxone 和aminoglycosides 配合使用時，對革蘭氏陰性細菌有協同殺菌作用。雖然這種合併療法的協同作用不一定會發生，但對一些微生物如*Pseudomonas aeruginosa* 所導致嚴重而有生命危險的感染時，仍必需考慮使用此種合併療法。因兩藥物在物理性上的不相容，投藥時須依建議劑量分開使用。

使用方法

通常溶液在調配完成後，應立即使用。

配製後之溶液，在室溫下，物理和化學的穩定性可維持6小時（或在2-8℃的冰箱下可達24小時）。依據調配濃度和貯存時間的不同，溶液顏色會呈淡黃色至琥珀色，溶液顏色並不影響本藥的效能和耐受性。

靜脈注射：靜脈注射時，Ceftriaxone 250 mg 或500 mg 溶於5 ml，或Ceftriaxone 1 g 溶於10 ml 的滅菌注射用水。靜脈注射的時間要超過2-4分鐘。

靜脈輸注：輸注時間至少須30分鐘。

不可使用含鈣溶液(例如 Ringer’s 溶液或 Hartmann’s 溶液)配製Ceftriaxone 小瓶或進一步稀釋已配製後之小瓶，因為會產生沉澱。當Ceftriaxone 與含鈣溶液在同一個靜脈注射管線混合時，也會發生 ceftriaxone-calcium 沉澱。Ceftriaxone 不應與含鈣靜脈注射液同時投與，包括含鈣溶液持續靜脈輸注，如經由 Y 型管投與之非腸道營養。然而，在新生兒以外的病人，如果可以在兩次輸注之間徹底以可相容的溶液沖洗輸注管，則可以相繼使用 Ceftriaxone 與含鈣溶液(見 2.4.4 與其他藥品交互作用以及其他形式的交互作用)目前並沒有資料顯示靜脈輸注ceftriaxone 與口服含鈣產品或肌肉注射ceftriaxone 與含鈣溶液或口服含鈣產品之間不會發生沉澱。

2.2.1 特殊劑量指示：

肝臟受損病人

病人腎功能正常而肝臟功能有損害時，不需調低劑量

腎臟受損病人

病人肝功能正常而腎功能不全時，不需要減低Ceftriaxone 劑量。只有在腎衰竭末期前(肌酐清除率小於 10 毫升/分鐘)的情況下，每日劑量不可超過 2 克。病人有嚴重的肝和腎功能不全時，須每隔固定時間測量 ceftriaxone 的血藥濃度，如果需要時應調整劑量。

在接受透析的患者不需在透析後給予額外的劑量，然而因為這些患者的排除速率會有所改變，一般須偵測 ceftriaxone 血藥濃度以決定是否需要調整劑量

老年人

服用成人建議劑量，毋需再調整劑量。

兒童

新生兒、嬰兒和至12歲的小孩：下列為每天給藥1次的建議劑量：

新生兒（至14天）：每日給藥20-50毫克/公斤體重。每日劑量不要超過50毫克/公斤。沒有必要去區分早產兒和足月嬰兒。Ceftriaxone 對於需要(或預期需要)接受含鈣溶液治療，包括含鈣溶液持續靜脈輸注如靜脈營養的新生兒(≤ 28 天)為使用禁忌，因為會有產生ceftriaxone-calcium 沉澱的風險(見 2.3 禁忌)。

新生兒、嬰兒和小孩（15天至12歲）：每日一次20-80毫克/公斤。

小孩體重大於50公斤就必需使用成人的一般劑量。

靜脈注射給藥劑量≥ 50毫克/公斤體重時，必須以輸注法給藥，而且給藥時間至少需超過 30 分鐘。

